

■ DATOS SINTÉTICOS - SOLO PARA PRUEBAS - NO ES PACIENTE REAL ■

Este documento fue generado automáticamente para el desarrollo del clinical-extractor de SICA. No contiene PHI ni representa una paciente real. Cualquier semejanza con un caso clínico real es coincidencia.

HISTORIA CLÍNICA OBSTÉTRICA — EMERGENCIA

Centro Materno-Infantil (sintético) — Emergencia Gineco-Obstétrica

FILIACIÓN

Nombre:	PACIENTE SINTÉTICA - NO REAL
Edad:	30 años
Estado civil:	Casada
Ocupación:	Comerciante
Fecha de ingreso:	12/04/2026 02:30

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

Fórmula obstétrica: G1 P0. Primigesta. Niega antecedentes de cirugía pélvica o infecciones de transmisión sexual.

GESTACIÓN ACTUAL

FUM:	12/08/2025
FPP:	19/05/2026
EG actual (por FUM):	34 semanas
Motivo de ingreso:	Ruptura prematura de membranas
Tiempo de RPM al ingreso:	8 horas

Paciente refiere pérdida de líquido por vía vaginal hace 8 horas, inicio súbito, líquido claro sin mal olor. Niega fiebre, escalofríos, dolor abdominal o sangrado. Movimientos fetales presentes y normales.

EXAMEN FÍSICO AL INGRESO

PA 112/72 mmHg. FC 84 lpm. T° 36.8°C (afebril). Peso 71.0 kg. AU 32 cm. LCF 144 lpm. Dinámica uterina ausente. Especuloscopia: salida espontánea de líquido amniótico claro a través del orificio cervical. Test de hehecho positivo. Tacto vaginal diferido para reducir riesgo de infección.

LABORATORIOS DE INGRESO (12/04/2026)

Analito	Resultado	Unidad	Observación
Hemoglobina	11.6	g/dL	Dentro de rango
Leucocitos	9800	/mm³	Sin leucocitosis significativa
PCR	0.8	mg/dL	No elevada
Glucosa	88	mg/dL	Normal
Urocultivo	Pendiente	—	Tomado al ingreso

ECOGRAFÍA RÁPIDA DE INGRESO

Feto único, vivo, presentación cefálica. Peso fetal estimado 2,150 g. ILA reducido (6 cm), compatible con oligoamnios secundario a RPM. Placenta posterior, no oclusiva. Doppler arteria umbilical normal.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

1. Embarazo de 34 semanas por FUM. 2. Ruptura prematura de membranas de 8 horas de evolución. 3. Sin signos clínicos ni laboratoriales de corioamnionitis al momento.

PLAN

1. Hospitalización en sala obstétrica. 2. Antibioticoterapia profiláctica con ampicilina + eritromicina según protocolo de RPM pretérmino. 3. Maduración pulmonar fetal con betametasona 12 mg IM c/24 h x 2 dosis. 4. Manejo expectante: monitoreo materno (PA, FC, T° c/6 h, leucograma diario) y fetal (NST diario, eco semanal). 5. Reevaluar inducción del parto a las 36-37

semanas o ante signos de infección o sufrimiento fetal.

Documento generado para fines de prueba del clinical-extractor de SICA. Sintético. No representa una paciente real.